

TEMA 6.5 • INFECTOLOGÍA

Infecciones Intrahospitalarias y Aislamientos

PERFIL EUNACOM 1.05.1.005

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Infecciones Intrahospitalarias (IIH) y Tipos de Aislamiento

Bacterias Resistentes y su Tratamiento

TABLA 6.5.1: BACTERIA VS CARACTERÍSTICA		
BACTERIA	CARACTERÍSTICA	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN
SAMR (Staphylococcus aureus meticilino-resistente)	Resistente a penicilinas	Vancomicina
Enterococo resistente a Ampicilina	Frecuente en IIH	Vancomicina
BLEE (Beta-lactamasa de espectro extendido)	Resistente a cefalosporinas y penicilinas. Se detecta si es resistente a múltiples cefalosporinas en el antibiograma.	Carbapenémicos (Meropenem, Imipenem). Nota: Ertapenem NO cubre Pseudomona.
Clostridium difficile	RAM de diarrea por ATB previo	Metronidazol oral → Metronidazol EV → Vancomicina oral (3ª línea). Siempre preferir VO.
Pseudomona aeruginosa / Acinetobacter	"Hermanos intrahospitalarios"	Quinolonas, Aminoglicósidos (Amikacina, Tobramicina), Cefalosporinas antipseudomónicas (Ceftazidima, Cefepime) o Carbapenémicos.

Tipos de Aislamiento

1. Precauciones Estándar (todas las atenciones)

- Lavado de manos o alcohol gel (antes y después de cada paciente) - Guantes al contacto con fluidos corporales

2. Aislamiento de Contacto

Medidas: Guantes + Pechera + Utensilios exclusivos **Indicaciones:** - Bacterias resistentes (SAMR, BLEE, Enterococo R, C. difficile) - Infecciones de transmisión fecal-oral (Rotavirus, E. coli, HAV)

3. Aislamiento por Gotas

Medidas: Todo lo anterior + **Mascarilla** (el germen se transmite por gotas > 5 µm, viajan < 1 metro) **Indicaciones:** - Virus Respiratorios

(Influenza, Parainfluenza, VRS) - **Meningitis bacteriana** (Meningococo, H. influenzae B)

4. Aislamiento Respiratorio (el más estricto)

Medidas: Mascarilla N95 + **Pieza individual** con presión negativa (germen en aerosoles < 5 µm, viajan por el aire largo tiempo)
Indicaciones: - **TBC pulmonar** - **Varicela (VZV)** - **Sarampión**

EUNACOM CRITERIOS
El aislamiento puede ser más estricto que lo mínimo requerido (es aceptable), pero nunca menos.

5. Aislamiento de Cohorte

Todos los pacientes con el **mismo agente infeccioso** agrupados en una misma sala. Se usa en brotes epidémicos (ej. campaña de invierno con influenza).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:
"Paciente hospitalizado desarrolla neumonía nosocomial. El antibiograma muestra resistencia a ceftriaxona, cefotaxima y ceftazidima, pero sensibilidad a imipenem. ¿Cuál es la interpretación más correcta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:
Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Infecciones Intrahospitalarias y Aislamientos. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- SAMR: vancomicina. BLEE: carbapenémicos. C. difficile: metronidazol oral (repetir si falla, última línea vancomicina oral).
- Bacterias BLEE se reconocen en antibiograma por resistencia a múltiples cefalosporinas. Ya no sirven cefalosporinas.
- Anti-Pseudomona: amikacina/tobramicina, ceftazidima/cefoperazona/cefepime, carbapenémicos (excepto ertapenem). Ceftriaxona NO cubre Pseudomona.
- Prevención más eficaz de infecciones intrahospitalarias: alta precoz del paciente.
- Aislamiento respiratorio (pieza sola, mascarilla siempre): solo TBC, varicela y sarampión.
- Aislamiento de gotitas (mascarilla <1m): virus respiratorios, meningococo, hemófilo.
- Aislamiento de contacto (guantes, pechera, utensilios exclusivos): bacterias resistentes y fecal-oral.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS Y AISLAMIENTOS)**PREGUNTA 1**

Paciente hospitalizado desarrolla neumonía nosocomial. El antibiograma muestra resistencia a ceftriaxona, cefotaxima y ceftazidima, pero sensibilidad a imipenem. ¿Cuál es la interpretación más correcta?

- A)** Es un estafilococo aureus meticilino resistente, tratar con vancomicina
- B)** Es una bacteria BLEE, tratar con carbapenémicos
- C)** Cambiar a cefepime que es cefalosporina de 4ta generación
- D)** Es Clostridium difficile, tratar con metronidazol oral
- E)** Cambiar a amikacina como aminoglucósido de primera línea

PREGUNTA 2

¿Cuál de las siguientes infecciones requiere aislamiento respiratorio con pieza individual?

- A)** Meningitis meningocócica
- B)** Influenza
- C)** Tuberculosis pulmonar
- D)** Hepatitis A
- E)** Infección por Pseudomona aeruginosa

PREGUNTA 3

Paciente con diarrea post-antibióticos. Se confirma Clostridium difficile. Se inicia metronidazol oral, pero no responde. Se repite metronidazol oral sin mejoría. ¿Cuál es el siguiente paso?

- A)** Metronidazol endovenoso
- B)** Vancomicina endovenosa
- C)** Vancomicina oral
- D)** Imipenem endovenoso
- E)** Ciprofloxacino oral

RESUMEN: INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS Y AISLAMIENTOS

Esta clase cubre las infecciones intrahospitalarias y los tipos de aislamiento. Las infecciones nosocomiales son frecuentes, graves y costosas, causadas por bacterias resistentes. Los principales agentes y sus tratamientos son: estafilococo aureus meticilino resistente (vancomicina, línea 2 linezolid), enterococo resistente a ampicilina (vancomicina), bacterias BLEE (carbapenémicos: ertapenem, meropenem, imipenem), Clostridium difficile (metronidazol oral, si falla repetir metro, última línea vancomicina oral), Pseudomona y Acinetobacter (quinolonas, aminoglucósidos anti-Pseudomona como amikacina/tobramicina, cefalosporinas anti-Pseudomona como ceftazidima/cefoperazona/cefepime, carbapenémicos excepto ertapenem que no cubre Pseudomona). La prevención más eficaz es el alta precoz. Los tipos de aislamiento son: precauciones estándar (lavado de manos, guantes con fluidos), contacto (guantes, pechera, utensilios exclusivos: bacterias resistentes, fecal-oral), gotitas (mascarilla a <1 metro, camas >1 metro: virus respiratorios, meningococo, hemófilo), respiratorio (mascarilla siempre, pieza sola: tuberculosis, varicela, sarampión) y cohorte (agrupar enfermos del mismo agente, útil en brotes).